MINISTERIO DE SALUD

No.073-2026/minsa

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

Lima, 20 de ENERO del 2026

Visto, el Expediente N° DVMSP20250000257, que contiene la Nota Informativa N° D003647-2025-DGIESP-MINSA, el Informe N° D000718-2025-DGIESP-DPCAN-MINSA y el Memorándum N° D006673-2025-DGIESP-MINSA de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; y, el Informe N° D001221-2025-OGAJ-MINSA y la Nota Informativa N° D000011-2026-OGAJ-MINSA de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, señalan que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;

Que, el numeral 1) del artículo 3 y el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establecen que el Ministerio de Salud es competente en salud de las personas, y que el Sector Salud está conformado por el Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y personas naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o indirecto en la salud, individual o colectiva;

Que, los literales b) y h) del artículo 5 del mencionado Decreto Legislativo establecen que son funciones rectoras del Ministerio de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de las enfermedades, recuperación, rehabilitación en salud, tecnologías en salud y buenas prácticas en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; y dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de la política nacional y políticas sectoriales de salud, la gestión de los recursos del sector, así como para el otorgamiento de derechos, fiscalización, sanción y ejecución coactiva en las materias de su competencia, entre otras funciones;

Que, la Ley N° 31336, Ley Nacional del Cáncer, tiene por objeto garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos, indistintamente al tipo de cáncer que padezcan, con la finalidad de asegurar el acceso al derecho fundamental a la salud en igualdad de condiciones y sin discriminación;

Que, el numeral 26.1 del artículo 26 del Reglamento de la Ley N° 31336, Ley Nacional del Cáncer, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2022-SA, define a la Red Oncológica Nacional como el conjunto de instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) públicas, privadas o mixtas del ámbito nacional, articuladas entre sí, que brindan servicios de salud oncológica relacionados al diagnóstico y atención integral oncológica. Está conformada por los institutos de enfermedades neoplásicas y todas las IPRESS que dispongan de las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud (UPSS) con una cartera de servicios de salud para la atención integral oncológica;

Que, de otro lado, el artículo 63 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, establece que la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública es el órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de Salud Pública, competente para dirigir y coordinar las intervenciones estratégicas de salud pública en materia de, entre otras, prevención y control del cáncer;

Que, con los documentos del visto, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública propone la aprobación de la Norma Técnica de Salud para la gestión de la Red Oncológica Nacional;

Con el visado de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, de la Dirección General de Personal de la Salud, de la Dirección General de Operaciones en Salud, de la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, del Instituto Nacional de Salud, de la Oficina General de Tecnologías de la Información, de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la Secretaría General, del Despacho Viceministerial de Salud Pública y del Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud, y por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de las enfermedades; y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, modificado mediante los Decretos Supremos N° 011-2017-SA y N° 032-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la NTS N° 241 -MINSA/DGIESP-2026, Norma Técnica de Salud para la gestión de la Red Oncológica Nacional, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en

MINISTERIO DE SALUD

No. 073-2026/MINSA

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

Lima, 20 de ENERO del 2026

la sede digital del Ministerio de Salud (www.gob.pe/minsa), en la misma fecha de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS NAPOLEÓN QUIROZ AVILÉS
Ministro de Salud

NTS N° 241 -MINSA/DGIESP-2026

NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA GESTIÓN DE LA RED ONCOLÓGICA NACIONAL

I. FINALIDAD

Contribuir a la disminución de la morbimortalidad por cáncer mediante la gestión de la Red Oncológica Nacional.

II. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Establecer las disposiciones para la mejora del acceso a la atención integral del cáncer en la Red Oncológica Nacional.

2.2. Objetivos específicos

2.2.1. Establecer disposiciones para la articulación y funcionamiento de los establecimientos de salud que conforman la Red Oncológica Nacional.

2.2.2. Promover la atención oportuna y precoz del usuario desde la sospecha, detección, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, seguimiento y cuidados paliativos.

2.2.3. Establecer disposiciones para la gestión de la información estandarizada e informatizada en la Red Oncológica Nacional.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Norma Técnica de Salud es de cumplimiento obligatorio en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud (MINSA), Gobiernos Regionales, Seguro Social de Salud (EsSalud), Sanidades de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, establecimientos de salud mixtos que integran la Red y que brindan servicios de salud para la atención integral oncológica; establecimientos de salud privados que se incorporen a ella; y en los establecimientos del primer nivel de atención, cuando corresponda. También es de aplicación para las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en Salud (IAFAS) públicas, privadas o mixtas del ámbito nacional, que brinden o gestionen la prestación y/o su financiamiento en el marco del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

IV. BASE LEGAL

- Ley Nº 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.
- Ley Nº 28343, Ley que declara de interés y necesidad pública la descentralización de los servicios médicos oncológicos.
- Ley Nº 28748, Ley que crea como Organismo Público Descentralizado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN.
- Ley N° 30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud (RIS).
- Ley Nº 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud.
- Ley Nº 31041, Ley de urgencia médica para la detección oportuna y atención integral del cáncer del niño y del adolescente.
- Ley Nº 31336, Ley Nacional del Cáncer, y sus modificatorias.

- Ley Nº 31561, Ley de prevención del cáncer en las mujeres y del fortalecimiento de la atención especializada oncológica.
- Decreto Supremo N° 020-2014-SA, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 024-2021-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31041, Ley de urgencia médica para la detección oportuna y atención integral del cáncer del niño y del adolescente.
- Decreto Supremo Nº 004-2022-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 31336, Ley Nacional del Cáncer, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo Nº 001-2024-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31561, Ley de prevención del cáncer en las mujeres y del fortalecimiento de la atención especializada oncológica.
- Decreto Supremo N° 019-2024-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud - RIS.
- Decreto Supremo N° 016-2025-SA, que aprueba el Plan Nacional Multisectorial para la lucha contra el cáncer 2025-2030.
- Resolución Ministerial Nº 751-2004/MINSA, que aprueba la NT N° 018-MINSA/DGSP-V01, Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud.
- Resolución Ministerial Nº 1213-2006/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 104-MINSA/DGSP V.01, Directiva Administrativa para el Funcionamiento de Departamentos/Servicios de Oncología/Unidades Oncológicas dedicadas al manejo integral del Cáncer en Hospitales del Ministerio de Salud.
- Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud Nº 021-MINSA/DGSP-V.03, Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud".
- Resolución Ministerial Nº 099-2014/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa Nº 197-MINSA/DGSP-V.01, Directiva Administrativa que establece la Cartera de Servicios de Salud.
- Resolución Ministerial Nº 802-2020/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria Nº 115-MINSA/2020/DGIESP, Directiva Sanitaria para la Organización de los Procesos de Atención Especializada en Oncohematología Pediátrica.
- Resolución Ministerial Nº 826-2021/MINSA, que aprueba las Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud.
- Resolución Ministerial Nº 239-2023/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud Nº 199-MINSA/CDC-2023, "Vigilancia epidemiológica de cáncer en general y cáncer en niños y adolescentes – Registro Hospitalario".
- Resolución Ministerial N° 876-2024/MINSA, que aprueba la NTS N° 218-MINSA/DGIESP-2024, Norma Técnica de Salud sobre el acceso a la cobertura oncológica.
- Resolución Ministerial N° 480-2025/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 165-MINSA/DGIESP-2025, Directiva Sanitaria para la prevención del cáncer de cuello uterino.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Siglas y Acrónimos:

DGIESP	Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública.
DIRESA	Dirección(es) Regional(es) de Salud.
DIRIS	Dirección(es) de Redes Integradas de Salud.
DPCAN	Dirección de Prevención y Control del Cáncer.
GERESA	Gerencia(s) Regional(es) de Salud
IAFAS	Institución(es) administradora(s) de fondos de aseguramiento en salud.
INEN	Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
INS	Instituto Nacional de Salud.
MINSA	Ministerio de Salud.
OGTI	Oficina General de Tecnologías de la Información
RENIPRESS	Registro Nacional de IPRESS.
RHC	Registro Hospitalario de Cáncer.
RIS	Red(es) Integrada(s) de Salud.
SIHCE	Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica.
UPSS	Unidad Productora de Servicios de Salud.

5.2. Definiciones operativas:

a) **Atención integral oncológica o atención integral al paciente oncológico en la Red Oncológica Nacional:** Atención que brinda el establecimiento de salud que integra la Red Oncológica Nacional, y que incluye diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos, seguimiento y las intervenciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el paciente con diagnóstico definitivo de cáncer, con el fin de asegurar su oportuna atención que permita disminuir la morbimortalidad por cáncer. Se brinda en los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de atención que cuenten con unidad de organización o unidad funcional oncológica. Dichos establecimientos de salud coordinan la participación de los establecimientos de salud del primer nivel, cuando corresponda.

b) **Cartera de servicios de salud**: Conjunto de diferentes prestaciones de salud individual y de salud pública que brinda la RIS, a través de los establecimientos de salud y servicios médico de apoyo, basado en sus recursos humanos y recursos tecnológicos, que responde a las necesidades de salud de la población y a las prioridades de políticas sanitarias sectoriales.

c) **Continuidad de servicios de salud**: Característica del Sistema de Salud de poder asegurar que los pacientes puedan ser atendidos de acuerdo al nivel de complejidad que requieran según la patología que les afecte, en los establecimientos de salud de los diferentes niveles

de atención, sin interrumpir la atención o tratamiento. Esto implica tener un operativo adecuado y oportuno flujo de referencia y contrarreferencia.

d) **Cuidado integral de la salud**: Son las acciones e intervenciones personales, familiares y comunitarias destinadas a promover hábitos y conductas saludables; buscan preservar la salud, recuperarla de alguna dolencia o enfermedad, rehabilitarse, paliar el sufrimiento físico o mental, y fortalecer la protección familiar y social. Comprende, por un lado, las intervenciones sanitarias de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud en torno a la persona, familia y comunidad, en el Sistema de Salud, considerando las dimensiones biopsicosociales de los individuos, aplicando los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad y equidad en salud. Además, comprende las intervenciones intersectoriales e intergubernamentales sobre las Determinantes Sociales de la Salud, bajo la Rectoría del Ministerio de Salud, abordando el marco socioeconómico político cultural, las determinantes estructurales y las determinantes intermedias, incluido el Sistema de Salud, con la finalidad de construir un país y una sociedad saludable.

e) **Cuidados paliativos**: Es la atención que se ofrece a pacientes y familias que sufren alguna enfermedad severa, generalmente crónica, progresiva, incurable e intratable, que limita o acorta la vida, y que se acompaña de una serie de síntomas y signos que requieren tratamiento. Como parte de la atención integral de salud, está comprendida dentro de la intervención sanitaria de recuperación en salud.

f) **Diagnóstico definitivo de cáncer:** Proceso de identificación de lesiones malignas tales como carcinoma u otros tipos de neoplasia, mediante el estudio histopatológico, y en algunos casos confirmada por inmunohistoquímica o incluso biología molecular.

g) **Diagnóstico presuntivo de cáncer:** Proceso de identificación de lesiones malignas, tales como carcinoma u otros tipos de neoplasia, donde no existe certeza del diagnóstico y/o éste requiere de algún resultado de estudio de anatomía patológica o de patología clínica u otros. Su carácter es provisional.

h) **Gestión clínica:** Es la gestión de los procesos asistenciales para la efectividad de la práctica clínica y la gestión de los recursos para la eficiente atención integral al paciente oncológico, que se brindan en las UPSS correspondientes. En la gestión clínica se deben utilizar herramientas de gestión clínica, como guías de práctica clínica, guías de procedimientos médicos y sanitarios, guías para búsqueda y análisis crítico de evidencias, vías de cuidado integral en salud, tablero de mando de indicadores de gestión clínica, y auditoría de la calidad de atención en salud, entre otros.

i) **Gestión sanitaria:** Conjunto de conceptos, principios, lineamientos y acciones vinculados a la gestión de organizaciones de salud, necesarios para generar la toma de decisiones acertadas con visión estratégica, con el objetivo de contribuir a mejorar el nivel de salud de la población de su influencia, promoviendo la mejora en la entrega de servicios de salud con calidad a sus usuarios. Incluye planificar, organizar, dirigir y controlar en el ámbito de salud. Se realiza a tres niveles: Macrogestión (política sanitaria de un territorio), mesogestión (en los establecimientos de salud) y microgestión o gestión clínica (la gestión de los profesionales de la salud en los servicios de los niveles operativos).

j) **Infraestructura digital:** Hace referencia a la tecnología informática requerida para la transformación digital, en términos de conectividad, seguridad de la información, interoperabilidad, almacenamiento, procesamiento, dispositivos, etc.

k) **Red Oncológica Nacional (en adelante, Red):** Conjunto de establecimientos de salud públicos, privados y mixtos del ámbito nacional, articulados entre sí, que brindan servicios de salud oncológica relacionados al diagnóstico y atención integral oncológica. Está conformada por los institutos de enfermedades neoplásicas y todos los establecimientos de salud que

dispongan de las UPSS con una cartera de servicios de salud para la atención integral oncológica.

l) **Transferencia tecnológica:** Proceso dinámico de transmisión de información científica, tecnología, conocimiento, de los medios y derechos de explotación, de un proveedor a un receptor, para la producción de un bien, el desarrollo de un proceso o la prestación de un servicio. En la práctica, los resultados de investigación que se transfieren incluyen una amplia gama de formas de propiedad intelectual (patente, derecho de autor, secreto industrial u otros) que, conjuntamente con el tipo de resultado (habilidades técnicas, diseños industriales, prototipos, software, procesos y *know how*), determinarán el mecanismo por el cual el conocimiento es transferido.

m) **Unidad Productora de Servicios de Salud:** Es la Unidad Productora de Servicios organizada para desarrollar funciones homogéneas y producir servicios de salud específicos, en relación directa con la cartera de servicios de salud del establecimiento de salud y su nivel de complejidad.

n) **Usuarios de la Red Oncológica Nacional:** Persona que recibe prestaciones de servicios de salud oncológicos de los establecimientos de salud integrantes de la Red en el territorio nacional, con integralidad, longitudinalidad y continuidad.

o) **Vigilancia epidemiológica de cáncer:** Se considera como una vigilancia epidemiológica especializada, y es el recojo sistemático de información de un conjunto de variables estandarizadas de pacientes con cáncer que acuden a los establecimientos de salud para diagnóstico y/o tratamiento, su análisis, elaboración de indicadores y diseminación de resultados para ser usados en la gestión sanitaria.

V. ALARCON G.

5.3. La Red Oncológica Nacional es una Red funcional que se articula con las RIS, con las cuales establece una relación sinérgica y complementaria en todo el territorio nacional. Asimismo, sus actividades se desarrollan en el marco de la rectoría y los instrumentos técnicos normativos que establece el Ministerio de Salud.

5.4. La Red promueve que los pacientes con sospecha y/o confirmación de cáncer reciban atención integral oncológica bajo estándares de buenas prácticas de atención de salud, de acuerdo a la capacidad resolutiva de cada establecimiento de salud.

5.5. De los procesos misionales de la Red

5.5.1. Sobre la implicancia de los procesos misionales de la Red

Los procesos misionales de la Red sustentan la importancia de su implementación en la medida que son la base para el logro del objeto establecido en el marco legal vigente de la Red.

Conseguir mejorar el acceso de los pacientes a la atención integral del cáncer en la Red, de manera oportuna, eficiente y de calidad, es lo que orienta a los procesos misionales. Esto implica tener en cuenta que la implementación de los mismos se relaciona, entre otros, con:

a) Gestión de las prestaciones de salud

Corresponde a la planificación, organización, dirección y control de las prestaciones de salud, que permitan:

- La planificación y organización de los servicios necesarios en todos los establecimientos de la Red, para la atención integral oncológica.
- La coordinación entre los establecimientos de salud conformantes de la Red, para atender las necesidades de atenciones integrales oncológicas, según capacidad resolutiva y de acuerdo a la normativa vigente.

- El impulso legal y normativo necesario para facilitar la articulación y complementariedad de los diferentes prestadores de servicios de salud relacionados con la atención integral del paciente con cáncer.

b) Gestión de la vigilancia epidemiológica en cáncer

Corresponde a la planificación, organización, dirección y control de la vigilancia epidemiológica en cáncer, que permita:

- El fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica, en relación del cáncer, con fines de prevención y control de la enfermedad, y la toma de decisiones correspondientes, garantizando el irrestricto respeto a los derechos de los pacientes.
- El involucramiento del personal de salud relacionado a la atención de los pacientes con cáncer con la finalidad de asegurar que se dispone de información actualizada, real y veraz que contribuya a la toma de decisiones en salud pública.

c) Gestión de la investigación en materia oncológica

Corresponde a la planificación, organización, dirección y control de la investigación en materia oncológica, que permita:

- El fomento de la investigación en salud referida al campo de la patología oncológica, para contribuir al conocimiento de la enfermedad en el contexto nacional, y al desarrollo de nuevas tecnologías en salud que se puedan implementar dentro de la Red.
- El fortalecimiento de las capacidades de los profesionales en la investigación en salud en materia oncológica, con solidez ética y el respeto a la dignidad de los pacientes y sus derechos como ciudadanos.

d) Gestión de transferencia tecnológica y normalización

Corresponde a la planificación, organización, dirección y control de la transferencia tecnológica y normalización, que permita:

- La inclusión en la agenda política del Estado y en la agenda institucional de los establecimientos de salud de la necesidad de planificar, organizar e implementar la transferencia tecnológica según el nivel de atención de los establecimientos de salud y de sus capacidades resolutivas, que cierren las brechas en capacidades de recursos humanos y de equipamiento.
- La valoración de disponer de documentos de gestión y de documentos normativos que garanticen la atención integral oncológica y dentro de márgenes de calidad, seguridad de la información, protección de datos personales y de responsabilidad social en salud.

e) Monitoreo y evaluación

Corresponde al monitoreo, evaluación y supervisión necesarios sobre los procesos de atención del paciente relacionados con la implementación de la Red, haciendo uso de los diversos mecanismos de monitoreo, evaluación y supervisión, que permitan demostrar si se cumplen los objetivos de la Red.

El desarrollo y la incorporación de instrumentos que faciliten el ejercicio del monitoreo, evaluación y supervisión, en los niveles que correspondan, incluida la gestión clínica, en los establecimientos de salud que conforman la Red.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1. DE LA ORGANIZACIÓN DE LA RED

6.1.1. La Red está conformada por todos los establecimientos de salud que señala el Anexo N° 1, y los establecimientos de salud que se integren posteriormente a la misma, que

brindan servicios de salud relacionados a la atención integral oncológica, asegurando la integralidad, longitudinalidad y continuidad. Dicho Anexo se actualiza de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6.1.4.

6.1.2. Los establecimientos de salud que conforman la Red son aquellos que, según su capacidad resolutiva, realizan lo siguiente:

a) Evaluación con un resultado positivo de tamizaje de cáncer o una sospecha de cáncer.

b) Intervenciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el paciente con diagnóstico definitivo de cáncer.

c) Diagnóstico del cáncer.

d) Tratamiento del cáncer.

e) Rehabilitación del paciente oncológico.

f) Seguimiento del paciente oncológico.

g) Cuidados paliativos del paciente oncológico.

Los integrantes de la Red tienen información actualizada sobre la cartera de servicios de salud asociados a la atención integral oncológica, de los establecimientos de salud que la conforman, identificando a nivel de las Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) de atención directa o de atención de soporte, la asociación con las prestaciones de salud que requiere el paciente oncológico (ver Anexo N° 2).

6.1.3. Los establecimientos de salud públicos, privados o mixtos cumplen con todos los siguientes criterios técnicos para su incorporación a la Red:

a) Tener en su cartera de servicios de salud una o más prestaciones de salud relacionadas a la atención integral oncológica.

b) Tener una o más UPSS de atención directa o de atención de soporte que produzcan prestaciones de salud relacionadas a la atención integral oncológica.

c) Contar con un código único en el RENIPRESS, y con categorización.

d) Tener implementado el sistema informático de referencias y contrarreferencias disponible para la continuidad de la atención integral oncológica.

e) Contar con una o más unidades de organización o unidades funcionales oncológicas.

6.1.4. La incorporación de los establecimientos de salud públicos, privados o mixtos a la Red, se realiza considerando lo siguiente:

La Dirección de Prevención y Control del Cáncer de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública actualiza y publica la lista de los establecimientos de salud que conforman la Red anualmente, ante la propuesta del INEN, para lo cual verifica el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos en el numeral 6.1.3.

6.1.5. Roles y responsabilidades de los integrantes de la Red

6.1.5.1. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, como conductor de la Red

a) Organiza la Red en el marco de la normativa establecida por el MINSA en coordinación con la DIRESA/GERESA o las que hagan sus veces a nivel regional, y las DIRIS a nivel de Lima Metropolitana, y a su vez con los responsables de los establecimientos de salud.

b) Gestiona los procesos misionales de la Red en coordinación con el MINSA y los diferentes establecimientos de salud que integran la Red.

c) Registra de forma trimestral la información sobre el monitoreo de la Red, y sobre el cumplimiento de indicadores a nivel de la Red.

d) Propone al MINSA los documentos normativos y estándares de calidad para la atención integral oncológica en los establecimientos de salud integrantes de la Red.

e) Fortalece las competencias en los profesionales de la salud de los establecimientos de salud integrantes de la Red, a través del Plan de Desarrollo de las Personas o plan de capacitación, según corresponda, para la atención integral oncológica, que incorpore acciones (cursos, talleres, pasantías) en los temas de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos y afines.

f) Realiza asistencia técnica para el fortalecimiento e implementación de servicios de salud oncológicos.

g) Participa en la formulación de la Política Nacional del Cáncer, conducida por el MINSA, para promover la atención integral oncológica.

6.1.5.2. Establecimientos de salud integrantes de la Red

Conforme a la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud:

a) Brindan atención integral al paciente oncológico con oportunidad, seguridad y calidad, e incentivan las buenas prácticas de atención establecidas para la Red, y articulan con los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo.

b) Realizan actividades de gestión para la referencia y contrarreferencia de los usuarios de la Red mediante el uso del sistema informático de referencias y contrarreferencias o el que haga sus veces.

c) Realizan la microgestión para la adecuada prestación de los servicios que brindan atenciones oncológicas.

6.1.6. Roles de los actores relacionados a la Red

6.1.6.1. Autoridad de Salud Nacional ejercida por el Ministerio de Salud

Realiza la supervisión, monitoreo y evaluación de los procesos correspondientes de la Red y, por ende, se encarga del monitoreo y evaluación del desempeño del INEN dentro de la Red.

6.1.6.2. Autoridad de Salud Regional o de Lima Metropolitana ejercida por la DIRESA/GERESA o DIRIS

a) Gestiona la dotación de recursos humanos especializados, desarrollo e implementación de la infraestructura, y equipamiento de los establecimientos de salud públicos integrantes de la Red dentro de su jurisdicción, para la atención integral del paciente oncológico; en coordinación con las instancias administrativas de mayor nivel de las diferentes entidades que brindan atenciones de salud, públicas y privadas del ámbito regional.

b) Supervisa los servicios de salud públicos relacionados a la atención integral al paciente oncológico, en el ámbito de su jurisdicción, y facilita el monitoreo y evaluación de estos en coordinación con el INEN.

6.1.6.3. Nivel local

a) Los gobiernos locales contribuyen, según el marco legal vigente, con la implementación de promoción de la salud y estrategias de prevención primaria del cáncer, en coordinación con la DIRESA/GERESA o DIRIS de su jurisdicción, así como con la RIS u otra instancia que considere pertinente.

b) Los establecimientos de salud del ámbito de competencia de la presente Norma Técnica de Salud brindan la atención integral oncológica, según capacidad resolutiva.

c) Los establecimientos de salud de las Redes Integradas de Salud, articulados con la Red, participan en la atención integral oncológica, según capacidad resolutiva.

6.2. DE LA ARTICULACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA RED

6.2.1. Articulación

a) La articulación en la Red se expresa implementando mecanismos efectivos para la atención integral oncológica entre los diferentes prestadores de servicios de salud y entre las diferentes IAFAS. Esta articulación incluye a los establecimientos de salud del primer nivel de atención y los servicios médicos de apoyo.

b) El INEN promueve, en el ámbito de sus competencias y según el marco legal vigente, la articulación de los establecimientos de salud integrantes de la Red, buscando la integración clínica y decisión clínica del prestador.

c) La articulación de la Red se realiza para promover el acceso a la atención integral oncológica de los usuarios de la misma, para lo cual es necesario que a nivel de la Red se cuente con la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos en salud, entre otros, propiciando el empleo racional y efectivo de los recursos disponibles.

6.2.2. Complementariedad de los establecimientos de salud en la Red

a) Los establecimientos de salud integrantes de la Red realizan las coordinaciones para asegurar la continuidad y calidad de las prestaciones de salud que necesita el usuario de la Red, incluyendo la complementariedad de los servicios de salud que se brindan en los establecimientos de salud del primer nivel de atención y los servicios médicos de apoyo, cuando corresponda.

b) Los establecimientos de salud integrantes de la Red complementan sus carteras de servicios de salud para la atención integral al paciente oncológico, evitando la duplicidad de prestaciones de salud.

c) Los establecimientos de salud de la Red coordinan, cuando se requiera, con la DIRESA/GERESA o las que hagan sus veces a nivel regional, y las DIRIS a nivel de Lima Metropolitana para complementar las prestaciones relacionadas a la atención integral oncológica.

6.2.3. Atenciones relacionadas con la referencia y contrarreferencia del paciente oncológico

a) Los establecimientos de salud del primer nivel de atención que realizan el tamizaje de cáncer e identifican un usuario con tamizaje positivo o sospecha de cáncer toman en consideración lo dispuesto en los numerales 6.2.2.2, 6.2.4 y 6.2.5.2 de la NTS 218-MINSA/DGIESP-2024, Norma Técnica de Salud sobre el acceso a la cobertura oncológica, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 876-2024-MINSA, o la que haga sus veces.

b) El acceso a servicios de salud oncológicos para la continuidad de la atención en la Red se realiza mediante referencia a través del sistema informático de referencias y contrarreferencias disponible, o el que haga sus veces, de acuerdo con la condición clínica del paciente y capacidad resolutiva de los establecimientos de salud integrantes de la Red, y teniendo en cuenta el flujo de atención que se presenta en el Anexo N° 03.

c) Los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de atención de salud que acepta la referencia evalúan al usuario con sospecha de cáncer o resultados positivos

de tamizaje de cáncer, solicitan los procedimientos diagnósticos y exámenes auxiliares requeridos para el diagnóstico, y en caso de un diagnóstico presuntivo o definitivo de cáncer, lo derivan a la unidad de organización o unidad funcional oncológica, según corresponda.

d) Los establecimientos de salud que cuentan con unidad(es) de organización o unidad(es) funcionales oncológica(s) realizan estadiaje del cáncer, atenciones de cirugía, quimioterapia, radioterapia, cuidados paliativos y tratamiento del dolor, rehabilitación del usuario con diagnóstico de cáncer, e intervenciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el paciente con diagnóstico definitivo de cáncer; y en caso se requieran atenciones para diagnóstico o tratamiento de alta especialización, se refiere al usuario a los institutos especializados o a establecimientos de salud del tercer nivel de atención pertenecientes a la Red, teniendo en cuenta su capacidad resolutiva.

e) En los casos excepcionales en los que el paciente acceda a los establecimientos de salud del segundo o tercer nivel de atención sin contar con la hoja de referencia, el establecimiento de salud atiende al paciente y es responsable de articular con la DIRESA/GERESA, DIRIS o establecimiento de salud de origen correspondiente, para la emisión y trámite de dicho documento y continuación de su atención oportuna. En estos casos, para garantizar la cobertura y el financiamiento de la atención de los asegurados, conforme con la normatividad vigente, las IAFAS incluyen una cláusula en los convenios respectivos vigentes, para establecer los procedimientos, mecanismos y modalidades de pago.

f) Los establecimientos de salud integrantes de la Red realizan la referencia o contrarreferencia para la continuidad de las atenciones de cuidados paliativos y tratamiento del dolor, teniendo en cuenta su capacidad resolutiva y, cuando corresponda, en coordinación con el primer nivel de atención.

g) Los establecimientos de salud integrantes de la Red realizan la contrarreferencia, según criterio clínico, que permita la continuidad de la atención del usuario.

6.3. DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED

6.3.1. Gestión en la Red por la autoridad de salud, ejercida a través de la DIRESA/GERESA, y DIRIS de Lima Metropolitana

a) Planifica, organiza, dirige y controla la oferta de los servicios de salud relacionados a la atención integral al paciente oncológico en su región, asegurando la oportuna y eficiente prestación de los mismos.

b) Reporta al INEN, la información necesaria para evaluar el desempeño de los establecimientos de salud conformantes de la Red.

c) Mantiene actualizado el número de camas hospitalarias, UPSS relacionadas a la atención integral al paciente oncológico, equipamiento, y recurso humano, entre otros.

d) Identifica la brecha de la existencia de disponibilidad, operatividad y mantenimiento de los activos estratégicos en su región, considerando a todos los prestadores de salud.

e) Gestiona la disponibilidad de recursos humanos especializados, infraestructura, equipamiento e inversiones en salud en materia oncológica, de acuerdo al marco normativo vigente.

f) Gestiona y brinda los recursos necesarios para que se hagan efectivas las capacitaciones en materia oncológica del personal de la salud que labora en los establecimientos de salud integrantes de la Red.

6.3.2. Gestión del Director del establecimiento de salud a nivel de la Red

a) Planifica, organiza, dirige y controla la producción de los servicios de salud relacionados a la atención integral al paciente oncológico, asegurando la oportuna y eficiente prestación de los mismos.

b) Gestiona la estandarización de los procedimientos relacionados a la atención integral al paciente oncológico, contribuyendo a la elaboración de las guías de práctica clínica y otros documentos normativos, de corresponder.

c) Identifica la brecha y gestiona la disponibilidad, operatividad y mantenimiento de los activos estratégicos relacionados a la atención integral al paciente oncológico, en coordinación con los responsables de las UPSS relacionadas a la atención integral al paciente oncológico.

d) Identifica la brecha y gestiona la dotación de recursos humanos especializados para la atención integral al paciente oncológico, en coordinación con los responsables de las UPSS relacionadas a la atención integral al paciente oncológico.

e) Identifica la brecha y gestiona la disponibilidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios requeridos para la atención integral al paciente oncológico, en coordinación con los responsables de las UPSS relacionadas a la atención integral al paciente oncológico, y de acuerdo al marco normativo vigente.

f) Gestiona el registro y seguimiento de los usuarios de la Red con diagnóstico presuntivo y definitivo de cáncer, en coordinación con los responsables de las UPSS relacionadas a la atención integral al paciente oncológico.

g) Gestiona las acciones de capacitación en materia oncológica del personal de la salud que labora en los establecimientos de salud integrantes de la Red.

6.3.3 Gestión del jefe de la unidad de organización oncológica, del coordinador de la unidad funcional oncológica o de los servicios relacionados a la atención oncológica

a) Gestiona la actualización de las prestaciones relacionadas a la atención integral al paciente oncológico en la cartera de servicios de salud de su establecimiento de salud.

b) Gestiona con las unidades de organización competentes la actualización de los procesos, procedimientos asistenciales y administrativos para el mejoramiento de la atención integral oncológica.

c) Gestiona la dotación del recurso humano, mantenimiento o implementación de la infraestructura o equipamiento necesario para la operatividad de la UPSS relacionada a la atención integral oncológica.

d) Coordina con la UPSS Farmacia el suministro oportuno de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios para la atención integral al paciente oncológico, de acuerdo al marco normativo vigente.

e) Gestiona acciones de capacitación continua para el profesional de la salud y personal administrativo, la cual debe ser incluida en el Plan de Desarrollo de las Personas o plan de capacitación, según corresponda.

f) Promueve el uso de las TIC (SIHCE, sistemas informáticos interoperables, telemedicina, entre otros).

g) Supervisa el correcto ingreso de los datos en el registro hospitalario de cáncer, según la normativa vigente.

h) Fomenta el desarrollo de investigación en cáncer, según las prioridades establecidas por el MINSA.

i) Gestiona la operatividad del servicio mediante las siguientes herramientas o instrumentos:

- Indicadores de gestión clínica.
- Herramientas de medición de adherencia de guías de práctica clínica, vías de cuidado integral en salud, sesión clínica (discusión de caso), evaluación de tecnologías sanitarias y guías de práctica clínica, entre otras.
- Documentos de gestión.
- Herramienta de gestión y mejora de los procesos.
- Herramientas de mejora continua de la calidad.
- Otros herramientas o instrumentos que faciliten la operatividad del servicio.

j) Gestiona el inicio del tratamiento oportuno, según el tipo de cáncer y estado del paciente, así como del manejo de complicaciones y otros cuidados, conforme a los estándares de buenas prácticas de atención al paciente oncológico.

k) Gestiona y promueve la telemedicina a nivel de la Red para la integración clínica de las prestaciones de salud que requiera el paciente con diagnóstico presuntivo o definitivo de cáncer.

l) Contribuye con la gestión y monitoreo de la ejecución de la referencia y contrarreferencia del paciente con diagnóstico presuntivo o diagnóstico definitivo de cáncer, a un establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva, teniendo en cuenta los tiempos establecidos, de acuerdo al marco normativo vigente.

m) En coordinación con la unidad de referencia o la que haga sus veces, acepta la referencia o contrarreferencia del establecimiento de salud de origen o destino, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 6.4. de la NTS N° 218-MINSA/DGIESP-2024, Norma Técnica de Salud sobre el acceso a la cobertura oncológica, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 876-2024/MINSA, o la que haga sus veces, según corresponda.

n) Participa de la formulación de documentos normativos sanitarios basados en evidencia para la atención integral al paciente oncológico.

6.4. DE LAS PRESTACIONES DE SALUD

6.4.1. Los establecimientos de salud de la Red aplican las Normas Técnicas de Salud, Directivas Sanitarias, Guías Técnicas, Guías de Práctica Clínica, entre otros documentos normativos vigentes, para la atención integral al paciente oncológico.

6.4.2. Los establecimientos de salud de la Red, según corresponda, brindan las prestaciones de salud acorde a lo dispuesto en la NTS N° 218-MINSA/DGIESP-2024, Norma Técnica de Salud sobre el acceso y cobertura oncológica, aprobada por Resolución Ministerial N° 876-2024-MINSA, o la que haga sus veces.

6.4.3. Los establecimientos de salud que integran la Red, de acuerdo a su capacidad resolutiva, brindan la atención integral oncológica y cumplen las normas que regulan la calidad de atención del paciente, para prevenir y reducir la ocurrencia de los eventos adversos durante la atención del paciente, practican la mejora continua de la calidad en dicha atención y realizan la medición de la calidad de la atención en salud, entre otras acciones.

6.5. DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN CÁNCER

a) La vigilancia epidemiológica especializada en cáncer es conducida y evaluada por el MINSA a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC).

b) Los establecimientos de salud integrantes de la Red que cuenten con diagnóstico y/o tratamiento de cáncer implementan el Registro Hospitalario de Cáncer (RHC), de acuerdo a la normativa vigente.

c) El análisis de la información en cáncer se realiza en todos los niveles. En los establecimientos de salud, la Oficina de Epidemiología o Inteligencia Sanitaria o la que haga sus veces, realiza un análisis de la información en forma trimestral, de acuerdo a la normatividad vigente.

d) Para el análisis de incidencia y mortalidad en la Red, se utilizan los datos provenientes del RHC, Registro de Cáncer de Base Poblacional y otros registros existentes.

6.6. DE LA INVESTIGACIÓN EN MATERIA ONCOLÓGICA

a) La investigación en materia oncológica se desarrolla en la Red, de acuerdo al marco normativo vigente y respetando la protección de datos personales.

b) El INEN promueve el desarrollo de investigación e innovación colaborativas en la Red en el marco de las Líneas Nacionales de Investigación en Salud, enfatizando la prevención de la enfermedad y promoción de la salud en materia oncológica.

c) Los establecimientos de salud de la Red promueven las investigaciones en materia oncológica a iniciativa propia o de manera colaborativa en el marco de la normatividad vigente.

d) El INEN brinda asistencia técnica en investigación e innovación y promueve la constitución y funcionamiento de los comités de ética e investigación de la Red, en el marco de la política nacional de ciencia y tecnología y de la normativa del INS.

e) El INEN formula y propone líneas y prioridades de investigación en oncología, en coordinación con el INS y los establecimientos de salud integrantes de la Red.

6.7. DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y NORMALIZACIÓN

6.7.1. Transferencia tecnológica

a) La transferencia tecnológica es parte del proceso de la innovación en salud.

b) Los establecimientos de salud que conforman la Red identifican las iniciativas de innovación en materia oncológica con potencial uso, con el soporte técnico del INS y del MINSA a través de OGTI, y las formalizan ante el INEN como conductor de la Red.

c) El INEN como conductor de la Red, en coordinación con el INS y MINSA a través de OGTI, promueve las acciones necesarias, mediante la transferencia tecnológica, para el desarrollo de la madurez tecnológica de la innovación.

d) El INEN, en coordinación con el INS y MINSA a través de OGTI, de corresponder, evalúan la pertinencia de las innovaciones para que, mediante la transferencia tecnológica, se incorporen en la Red.

6.7.2. Elaboración de normativa relacionada o normalización

Corresponde al INEN proponer al Ministerio de Salud los documentos normativos que se requieran para garantizar la correcta implementación y aplicación, en los establecimientos de salud de la Red, de la transferencia tecnológica que se haga en la misma. Los establecimientos de salud de la Red son responsables de realizar las actividades necesarias de elaboración de normativa que les corresponda, en aplicación de lo dispuesto en el presente literal.

6.8. MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

6.8.1. Monitoreo de la Red

a) Nivel del MINSA

El MINSA a través de la DPCAN, monitorea al INEN y a la Red, según corresponda, y de considerarlo pertinente coordina con las direcciones y/u oficinas respectivas para su participación en el monitoreo. La DPCAN presenta los resultados del monitoreo a la DGIESP.

b) Nivel del INEN

El INEN como conductor de la Red, realiza el monitoreo de la operación y funcionamiento de los servicios o UPSS relacionadas a la atención integral oncológica de los establecimientos de salud que conforman la misma, a través de la herramienta digital de la Red y en coordinación con las áreas correspondientes.

6.8.2. Supervisión en la Red

a) Nivel del MINSA

El MINSA, a través de la DPCAN, realiza la supervisión de la Red, según corresponda, en base a la información de la supervisión realizada por el INEN y, de considerarlo pertinente coordina con las direcciones y/u oficinas respectivas para su participación en la supervisión. La DPCAN presenta los resultados de la supervisión a la DGIESP.

b) Nivel del INEN

El INEN, como conductor de la Red, realiza la supervisión en los establecimientos de salud que conforman la Red, en coordinación con la DIRESA/GERESA o las que hagan sus veces a nivel regional, y las DIRIS a nivel de Lima Metropolitana. Los resultados de la supervisión se presentan a la DPCAN.

6.8.3. Evaluación de la Red

a) Nivel del MINSA

El MINSA realiza la evaluación del desempeño de la Red, en base a la información remitida por el INEN como conductor, a través de la DPCAN de forma trimestral. DPCAN presenta los resultados de la evaluación a la DGIESP.

b) Nivel del INEN

El INEN realiza la evaluación de la Red en forma trimestral, basado en indicadores de desempeño de la Red que incluya el nivel regional y por establecimientos de salud, y presenta un informe a la DPCAN con los resultados de la evaluación.

6.9. DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTANDARIZADA EN LA RED

6.9.1. El MINSA a través de la DPCAN establece los criterios técnicos funcionales, y es responsable de la gestión global de los usuarios de la herramienta digital de la Red, en coordinación con el INEN y el CDC.

6.9.2. El MINSA a través de la OGTI diseña, pone a disposición y mantiene actualizada la herramienta digital de la Red, para la gestión de la información relacionada a los procesos de atención integral del paciente oncológico, que incluya los tiempos de espera para la atención oncológica del usuario de la Red. La herramienta digital de la Red debe incorporar estándares de interoperabilidad en salud, para contar con información integrada y segura de la atención integral oncológica entre los establecimientos de salud de la Red; teniendo como sistema de registro de la información sus respectivos SIHCE o el sistema de información que permita el registro de la atención integral oncológica.

6.9.3. Todo tratamiento de datos personales, incluyendo el acceso y uso de la información de la Red, sigue estrictamente las disposiciones de la Ley N° 29733, Ley de protección de

datos personales, y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 016-2024-JUS, o la normativa que haga sus veces.

6.9.4. La OGTI establece las reglas de acceso y uso de la herramienta digital de la Red, de modo que permita el tratamiento de datos estrictamente necesarios para la ejecución de las actividades de cada uno de los roles definidos por DPCAN-MINSA, referente al tamizaje de cáncer positivo o una sospecha de cáncer, diagnóstico del cáncer, tratamiento del cáncer, rehabilitación del cáncer, seguimiento del paciente oncológico y cuidados paliativos del cáncer.

6.9.5. Los establecimientos de salud pertenecientes a la Red son responsables de la veracidad e integralidad de la información que se registra, y que es compartida en la herramienta digital de la Red, en relación a la calidad y oportunidad del dato registrado, en el marco de lo requerido por la Red.

6.9.6. Los profesionales de la salud de los establecimientos de salud de la Red sólo pueden acceder a la información que contiene datos personales relacionados con la salud de los usuarios de la Red que atienden en dicho establecimiento de salud. En ningún caso se debe acceder desde otras instancias a dicha información sin cumplir con los procedimientos establecidos por Ley.

6.9.7. El MINSA, las DIRESA/GERESA, DIRIS, el INEN, como conductor de la Red, y los establecimientos de salud que pertenecen a la Red, acceden a información estadística y anonimizada, teniendo como fuente la herramienta digital de la Red.

6.9.8. La herramienta digital de la Red sustenta la información para la evaluación de los indicadores propuestos en el Anexo N° 4.

6.10. DEL FINANCIAMIENTO DE LA RED

6.10.1. El financiamiento de las prestaciones de salud del paciente que se atiende en la Red, se realiza con cargo al presupuesto institucional asignado a las unidades ejecutoras, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de financiamiento aplicables, según la normativa vigente de la materia.

6.10.2. Las IAFAS financian las prestaciones de salud para la atención del paciente que se atiende en la Red, según sus planes de aseguramiento en salud.

VII. RESPONSABILIDADES

7.1. En el nivel nacional

El MINSA, a través de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, es responsable de la difusión de la presente Norma Técnica de Salud hasta el nivel regional, así como de brindar asistencia técnica, supervisar y evaluar su cumplimiento.

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas como conductor de la Red es responsable de la implementación y aplicación de la presente Norma Técnica de Salud, así como de brindar asistencia técnica, supervisar y evaluar su implementación.

7.2. En el nivel regional

Las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA), Gerencias Regionales de Salud (GERESA), y las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) en el ámbito de Lima Metropolitana, son responsables de la difusión, asistencia técnica, implementación, supervisión y evaluación del cumplimiento del presente documento normativo en su jurisdicción.

7.3. En el nivel local

Los establecimientos de salud son responsables de la aplicación de lo dispuesto en el presente

documento normativo, en lo que corresponda.

VIII. ANEXOS

Anexo N° 1: Listado de establecimientos de salud del nivel II y III que conforman la Red Oncológica Nacional.

Anexo N° 2: Relación de UPSS con principales prestaciones de salud relacionadas con la atención integral oncológica en los establecimientos de salud de la Red.

Anexo N° 3: Flujo de referencia y contrarreferencia de la Red Oncológica Nacional.

Anexo N° 4: Indicadores de la Red Oncológica Nacional.

ANEXO N° 1

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NIVEL II Y III QUE CONFORMAN LA RED ONCOLÓGICA NACIONAL

N°	UBICACIÓN	DEPENDENCIA	CÓDIGO RENIPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA DEL E.S.
1	Lima Metropolitana	MINSA	7632	Hospital Carlos Lanfranco la Hoz	II-2
2			5617	Hospital San Juan de Lurigancho	II-2
3			7633	Hospital Nacional Cayetano Heredia	III-1
4			23159	Hospital de Emergencias Villa El Salvador	III-1
5			6211	Hospital de Apoyo Santa Rosa	III-1
6			5987	Hospital María Auxiliadora	III-1
7			6207	Hospital Nacional Arzobispo Loayza	III-1
8			6215	Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé	III-1
9			6206	Hospital Nacional Dos de Mayo	III-1
10			5946	Hospital Nacional Hipólito Unanue	III-1

11		6210	Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas	III-2
12		16918	Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja	III-2
13		6216	Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña	III-2
14		6208	Instituto Nacional Materno Perinatal	III-2
15		7634	Hospital Nacional Sergio E. Bernales	III-1
16	ESSALUD	8720	Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins	III-2
17		10533	Hospital II Lima Norte Callao "Luis Negreiros Vega"	II-2
18		8265	Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de la Red Asistencial Sabogal	III-1
19		8502	Hospital de Emergencias Grau	II-2

20			9251	Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen	III-2
21		SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ	13591	Hospital Nacional Policía Nacional del Perú General PNP Luis N. Sáenz	III-1
22		SANIDAD DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ	10751	Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú	III-1
23		SANIDAD DEL EJÉRCITO DEL PERÚ	17024	Hospital Militar Luis Arias Schreiber	III-1
24	Amazonas	DIRESA Amazonas	4838	Hospital Regional Virgen de Fátima de Chachapoyas	II-2
25	Áncash	DIRESA Áncash	1543	Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz	II-2
26			1703	Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón	II-2
27	Apurímac	DIRESA Apurímac	7719	Hospital Regional Guillermo Díaz de La Vega	II-2
28			11213	Hospital II ESSALUD Abancay	II-2

29		ESSALUD (Red Asistencial Apurímac)	11214	Hospital I Santa Margarita Andahuaylas-ESSALUD	II-1
30	Arequipa	GERESA Arequipa	1231	Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza	III-1
31			1232	Hospital III Goyeneche	III-1
32			7397	Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur - IREN Sur	III-2
33		ESSALUD (Red Asistencial Arequipa)	13290	Hospital Nacional III-1-Carlos Alberto Seguín Escobedo	III-1
34	Ayacucho	DIRESA Ayacucho	3543	Hospital Regional de Ayacucho "Miguel Ángel Mariscal Llerena"	II-2
35	Cajamarca	DIRESA Cajamarca	4210	Hospital General de Jaén	II-2
36			7686	Hospital Regional Docente Cajamarca	II-2
37		ESSALUD (Red Asistencial Cajamarca)	10272	Hospital II Cajamarca	II-2
38	Callao	DIRESA Callao	6218	Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión	III-1

39			6219	Hospital San José	II-2
40		SANIDAD DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ	8266	Centro Médico Naval "Cirujano Mayor Santiago Távara"	III-1
41	Cusco	DIRESA Cusco	2305	Hospital Antonio Lorena del Cusco	III-1
42			2289	Hospital de Apoyo Departamental - Cusco	III-1
43		ESSALUD (Red Asistencial Cusco)	10041	Hospital Adolfo Guevara Velasco	III-1
44	Huancavelica	DIRESA Huancavelica	3853	Hospital Departamental de Huancavelica	II-2
45	Huánuco	DIRESA Huánuco	754	Hospital Regional Hermilio Valdizán	II-2
46	Ica	DIRESA Ica	3358	Hospital Regional de Ica	II-2
47			3359	Hospital Santa María del Socorro	II-1
48			3414	Hospital San José de Chincha	II-1
49		ESSALUD (Red Asistencial Ica)	16374	Hospital IV Augusto Hernández Mendoza	II-2

50	Junín	DIRESA Junín	753	Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión de Huancayo	III-E
51			27857	Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro - IREN Centro	II-E
52		ESSALUD (Red Asistencial Junín)	8652	Hospital Nacional "Ramiro Prialé Prialé"	III-1
53	La Libertad	GERESA La Libertad	5195	Hospital Belén de Trujillo	III-1
54			5196	Hospital Regional Docente de Trujillo	III-1
55			7277	Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Norte - IREN Norte - Dr. Luis Pinillos Ganoza	III-2
56		ESSALUD (Red Asistencial La Libertad)	9042	Hospital Víctor Lazarte Echegaray	III-1
57			20925	Hospital de Alta Complejidad de La Libertad Virgen de la Puerta	III-E

58	GERESA Lambayeque	Lambayeque	4317	Hospital Regional Docente "Las Mercedes"	II-2
59			11470	Hospital Regional Lambayeque	III-1
60		ESSALUD (Red Asistencial Lambayeque)	8577	Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo	III-1
61	Lima Región	DIRESA Lima	5986	Hospital Rezola	II-2
62			7635	Hospital de Barranca	II-2
63			7637	Hospital San Juan Bautista Huaral	II-2
64			7639	Hospital Regional de Huacho	II-2
65	Loreto	DIRESA Loreto	3	Hospital Regional de Loreto "Felipe Santiago Arriola Iglesias"	III-1
66		ESSALUD (Red Asistencial Loreto)	11409	Hospital III Iquitos	III-1
67	Madre De Dios	DIRESA Madre De Dios	2698	Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado	II-1
68	Moquegua	DIRESA Moquegua	7732	Hospital Regional de Moquegua	II-2
69		ESSALUD (Red Asistencial Moquegua)	16157	Hospital II Moquegua	II-1

70	Pasco	DIRESA Pasco	979	Hospital Regional Dr. Daniel Alcides Carrión García	II-2
71		ESSALUD (Red Asistencial Pasco)	9747	Hospital II Pasco	II-2
72			9749	Hospital II-E Huariaca	II-E
73	Piura	DIRESA Piura	1910	Hospital de Apoyo II-2 Sullana	II-2
74			2084	Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2 de Piura	II-2
75		ESSALUD (Red Asistencial Piura)	15230	Hospital III José Cayetano Heredia	III-1
76	Puno	DIRESA Puno	3251	Hospital Manuel Núñez Butron	II-2
77			3299	Hospital Carlos Monje Medrano	II-2
78		ESSALUD (Red Asistencial Puno)	9215	Hospital III Base (Puno) – Red Asistencial Puno	II-2
79	DIRESA San Martín	San Martín	6352	Hospital II-E Lamas	II-E
80			6733	Hospital II-1 Moyobamba "Alpino Acosta Ruiz"	II-1
81			6918	Hospital Tarapoto	II-2

82	Tacna	DIRESA Tacna	2864	Hospital Hipólito Unanue de Tacna	II-2
83		ESSALUD (Red Asistencial Tacna)	10185	Hospital III Daniel Alcides Carrión ESSALUD Red de Tacna	II-2
84	Tumbes	DIRESA Tumbes	17077	Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría Jamo II-2 Tumbes	II-2
85		ESSALUD (Red Asistencial Tumbes)	12272	Hospital Carlos Alberto Cortez Jiménez	II-1
86	Ucayali	DIRESA Ucayali	5576	Hospital Regional de Pucallpa	II-2
87		ESSALUD (Red Asistencial Ucayali)	9600	Hospital II Pucallpa-ESSALUD	II-2

ANEXO N° 2

RELACIÓN DE UPSS CON PRINCIPALES PRESTACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN INTEGRAL ONCOLÓGICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED

Intervención	UPSS	Prestación de salud	Capacidad resolutiva esperada
Diagnóstico	Consulta Externa	Consulta ambulatoria por médico especialista: - Ginecología y obstetricia. - Gastroenterología. - Urología. - Pediatría. - Oftalmología. - Dermatología. - Neumología. - Otros.	Establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que cuenta con la capacidad resolutiva para la evaluación del usuario(a) con tamizaje positivo de cáncer, o con sospecha diagnóstica de cáncer.
Diagnóstico	Consulta Externa	Atención de procedimientos ambulatorios: Biopsias, endoscopías altas y bajas, broncoscopia, otros.	Establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que cuenta con la capacidad resolutiva para realizar procedimientos ambulatorios para el diagnóstico de cáncer.
	Consulta Externa	Consulta ambulatoria por médico especialista: - Ginecología y obstetricia. - Gastroenterología. - Urología. - Pediatría. - Oftalmología. - Dermatología. - Neumología. - Otros.	Establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que cuenta con capacidad resolutiva para identificar a paciente con estudio anatomopatológico positivo de cáncer y sospecha de cáncer, refiriendo al paciente a tiempo para tratamiento o diagnóstico definitivo.

Intervención	UPSS	Prestación de salud	Capacidad resolutiva esperada
	Anatomía Patológica	Procedimientos de anatomía patológica: • Estudios citopatológicos. • Estudios histopatológicos. • Inmunohistoquímica. • Citogenética. • Biología molecular.	Establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que cuenta con capacidad resolutiva para realizar procedimientos de anatomía patológica.
	Patología clínica	Procedimiento de laboratorio clínico: • Microbiología - Biología molecular. • Hematología. • Inmunología. • Bioquímica. • Histocompatibilidad.	Establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que cuenta con capacidad resolutiva para realizar procedimientos de laboratorio clínico.
	Diagnóstico por imágenes	- Radiología convencional. - Radiología intervencionista. - Ecografía general y Doppler. - Mamografía - Tomografía axial computarizada. - Resonancia magnética.	Establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que cuenta con capacidad resolutiva para realizar los exámenes de diagnóstico por imágenes.
	Medicina nuclear	Examen de captación de sustancias radioactivas.	Establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que cuenta con capacidad resolutiva para atención de procedimientos con el uso de radiotrazadores o radiofármacos para estadiaje y diagnóstico.
Tratamiento	Consulta Externa	Consulta ambulatoria y atención de procedimientos ambulatorios por especialidades oncológicas: - Cirugía oncológica. - Cirugía oncológica abdominal.	Establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que cuenta con capacidad resolutiva para brindar atención de consulta ambulatoria y atención de

Intervención	UPSS	Prestación de salud	Capacidad resolutiva esperada
		- Cirugía oncológica de cabeza y cuello. - Cirugía oncológica de mama, tejidos blandos y piel. - Ginecología oncológica. - Medicina oncológica. - Oftalmología oncológica. - Oncología pediátrica. - Radioterapia - Urología oncológica. Consulta ambulatoria y atención por médico especialista: - Hematología. - Oftalmología. - Ortopedia y Traumatología. - Cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial. - Cirugía de tórax y cardiovascular. - Otros Atención ambulatoria por psicólogo(a), nutricionista y otros profesionales de la salud.	procedimientos ambulatorios por especialidades oncológicas.
	Hospitalización	Hospitalización de especialidades relacionadas a la atención integral oncológica.	Establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que cuenta con capacidad resolutiva para hospitalización de especialidades.
	Centro Quirúrgico	Intervención quirúrgica por médico especialista: - Cirugía oncológica. - Cirugía oncológica abdominal. - Cirugía oncológica de cabeza y cuello. - Cirugía oncológica de mama, tejidos blandos y piel. - Ginecología oncológica.	Establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que cuenta con capacidad resolutiva para la realización de intervenciones quirúrgicas por médico especialista.

Intervención	UPSS	Prestación de salud	Capacidad resolutiva esperada
		- Medicina oncológica. - Oftalmología oncológica. - Ortopedia y Traumatología. - Cirugía plástica. - Cirugía pediátrica. - Neurocirugía - Atención en sala de recuperación post anestésica.	
	Radioterapia	Atención con radioterapia interna (Braquiterapia). Atención con radioterapia externa (Teleterapia).	Establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que cuenta con capacidad resolutiva para el tratamiento con teleterapia, y braquiterapia de alta tasa en el paciente oncológico.
	Quimioterapia	Atención con quimioterapia ambulatoria parenteral. Atención con quimioterapia ambulatoria regional. Atención de soporte concomitante a quimioterapia.	Establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que cuenta con capacidad resolutiva para el tratamiento con quimioterapia en el paciente oncológico.
	Farmacia	Atención en farmacia clínica. Atención en farmacotecnia (que incluye la Unidad de mezclas oncológicas).	Establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que cuenta con capacidad resolutiva para las atenciones en farmacia clínica y farmacotecnia.
	Medicina nuclear	Examen de captación de sustancias radioactivas.	Establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que cuenta con capacidad resolutiva para la atención de procedimientos con el uso de radiotrazadores o radiofármacos para evaluar respuesta al tratamiento y reestadiaje.

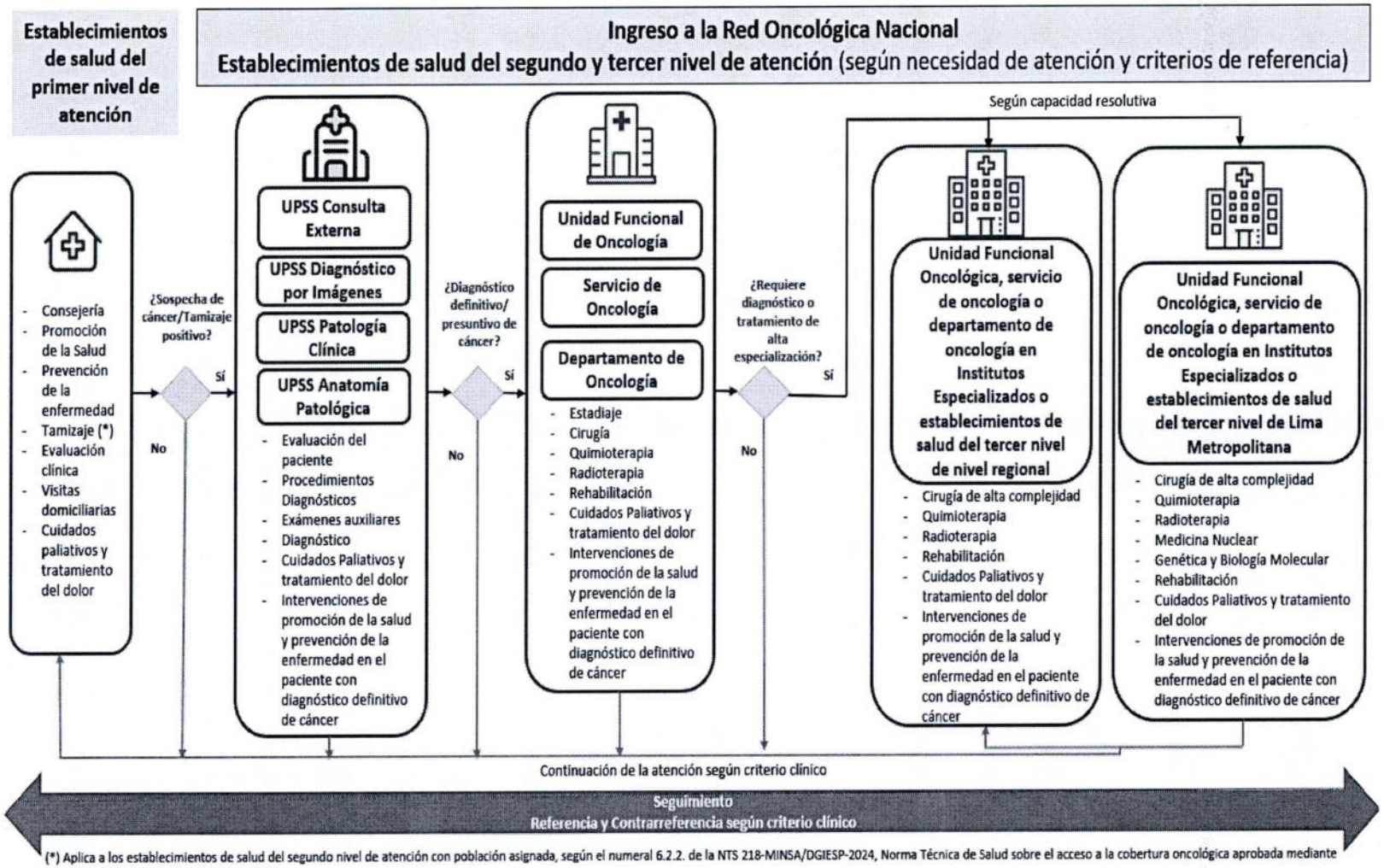
Intervención	UPSS	Prestación de salud	Capacidad resolutiva esperada
		Tratamiento con radioisótopos.	Establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que cuenta con capacidad resolutiva para tratamiento con radiotrazadores terapéuticos en el paciente oncológico.
	Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre	Preparación de unidades de sangre y hemoderivados. Provisión de unidades de sangre y hemoderivados.	Establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que dispone de unidades de sangre y hemoderivados para el tratamiento del paciente oncológico. Puede realizar procedimientos terapéuticos (aféresis terapéutica y otros).
	Cuidados Intensivos	Atención en la Unidad de Cuidados Intensivos General. Atención en la Unidad de Cuidados Intermedios General. Atención en la Unidad de Cuidados Intensivos de otras especialidades médicas.	Establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que cuenta con capacidad resolutiva para brindar la atención al paciente oncológico, en la unidad de cuidados intensivos con soporte de equipo multidisciplinario de salud.
	Emergencia	Atención de urgencias y emergencias por médicos especialistas.	Establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que cuenta con capacidad resolutiva para brindar la atención oncológica de emergencia del paciente oncológico, en coordinación con médicos especialistas en medicina oncológica, cirugía oncológica y otros.
	Nutrición y dietética	Evaluación nutricional en hospitalización.	Establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que cuenta con capacidad resolutiva para realizar

Intervención	UPSS	Prestación de salud	Capacidad resolutiva esperada
		Soporte nutricional con regímenes dietéticos. Soporte nutricional con fórmulas enterales.	prestaciones asociadas a la evaluación nutricional, diagnóstico nutricional, cálculo de necesidades nutricionales, elaboración del plan nutricional, monitorización y seguimiento del estado nutricional del paciente oncológico.
Rehabilitación	Consulta Externa	Consulta ambulatoria y atención de procedimientos ambulatorios por médicos especialistas en medicina física y de rehabilitación.	Establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que cuenta con capacidad resolutiva para brindar atención de consulta ambulatoria y atención de procedimientos ambulatorios por médicos especialistas en medicina física y de rehabilitación.
	Medicina de Rehabilitación	Atención de rehabilitación mediante procedimientos de terapia física. Atención de rehabilitación mediante procedimientos de terapia ocupacional. Atención de rehabilitación mediante procedimientos de terapia de lenguaje.	Establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que cuenta con capacidad resolutiva para que realicen atención de rehabilitación al paciente oncológico.
Cuidados paliativos	Consulta Externa, otras UPSS y actividades	Consulta ambulatoria por médico especialista. Manejo del dolor. Atención de procedimientos ambulatorios. Atención ambulatoria de psicología y nutrición. Visita domiciliaria, entre otros.	Establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que cuenta con capacidad resolutiva para realizar la atención de cuidados paliativos y tratamiento del dolor al paciente oncológico.

De acuerdo a la necesidad del paciente oncológico, pueden indicarse otras UPSS, prestaciones y especialidades que requiera el paciente oncológico como parte de su atención integral.

ANEXO N° 3

FLUJO DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DE LA RED ONCOLÓGICA NACIONAL



(*) Aplica a los establecimientos de salud del segundo nivel de atención con población asignada, según el numeral 6.2.2. de la NTS 218-MINSA/DGIESP-2024, Norma Técnica de Salud sobre el acceso a la cobertura oncológica aprobada mediante Resolución Ministerial N° 876-2024-MINSA

ANEXO N° 4

INDICADORES DE LA RED ONCOLÓGICA NACIONAL

N°	Indicador	Fórmula	Responsable
1	Porcentaje de pacientes con diagnóstico de cáncer en estadios clínicos tempranos.	(Número de pacientes de cáncer diagnosticados en estadios tempranos/Número total de pacientes con diagnóstico definitivo de cáncer) *100	CDC
2	Porcentaje de pacientes con diagnóstico de cánceres prevalentes que inician tratamiento oncológico en un tiempo no mayor a 37 días.	(Número de pacientes con inicio de tratamiento oncológico <=37 días en relación a la fecha del diagnóstico definitivo de cáncer prevalente/Número total pacientes con diagnóstico definitivo de cáncer prevalente) *100	DPCAN
3	Porcentaje de pacientes con referencia registrada en el establecimiento de salud de destino que cuentan con diagnóstico definitivo de cáncer prevalente, en un tiempo no mayor a 28 días.	(Número de pacientes con entrega del diagnóstico definitivo de cáncer prevalente <= 28 días en relación a la fecha de referencia registrada para diagnostico en el establecimiento de destino/Número total de pacientes referidos para diagnóstico definitivo de cáncer registrados en el establecimiento de salud de destino) *100.	DPCAN
4	Tasa de mortalidad estandarizada por edad según tipo de cáncer y región.	La construcción del indicador sigue el procedimiento descrito por OPS en el documento *Tasas de mortalidad por edad estandarizada por Población de 100,000.*	DPCAN
5	Tasa de supervivencia a los cinco (5) años del diagnóstico definitivo de cáncer.	La construcción del indicador sigue el procedimiento estadístico, método de estimación de la supervivencia por el método de Kaplan-Meier.	CDC
6	Porcentaje de establecimientos de salud que reportan información en la herramienta digital de la Red.	El cálculo del indicador se realiza mediante el método de estimación de supervivencia de Kaplan-Meier.	DPCAN
7	Porcentaje de pacientes nuevos con diagnóstico definitivo de cánceres prevalentes en la Red Oncológica Nacional.	(Número de pacientes nuevos con diagnóstico definitivo de cánceres prevalentes atendidos en la Red/ Número estimado de casos nuevos de cánceres prevalentes) *100	INEN

Ficha N° 1: Porcentaje de pacientes con diagnóstico de cáncer en estadios clínicos tempranos

Nombre	Porcentaje de pacientes con diagnóstico de cáncer en estadios clínicos tempranos.
Tipo	Indicador de desempeño.
Ámbito de Aplicación	Nacional Por tipo de prestador. Por establecimiento.
Definición	Porcentaje de pacientes con cáncer diagnosticados en estadio temprano respecto al total de pacientes con diagnóstico definitivo de cáncer.
Justificación	La detección temprana mejora el pronóstico de los pacientes oncológicos y optimiza la eficiencia de las intervenciones de control y prevención del cáncer.
Fórmula del indicador	N° de pacientes con cáncer diagnosticados en estadios tempranos ----------x100 N° total de pacientes con diagnóstico definitivo de cáncer en el periodo
Construcción del indicador	**Numerador:** Número de pacientes con cáncer diagnosticados en estadios tempranos. **Denominador:** Número total de pacientes con diagnóstico definitivo de cáncer en el periodo. **Indicador:** (Numerador/denominador) *100.
Estándar	≥ 60% de los cánceres prevalentes (cuello uterino, mama, próstata, colon y recto, estómago, cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, linfoma y leucemia)
Valor basal	Valor obtenido en el año anterior (enero-diciembre).
Valor umbral (logro esperado)	Incremento anual del 10% sobre el basal del indicador.
Cálculo del porcentaje de cumplimiento	Incremento del valor umbral.
Frecuencia de medición	Trimestral anual acumulada.
Fuente de datos	Herramienta digital de la Red Oncológica Nacional.

	Registro Hospitalario de Cáncer (RHC).
Área responsable técnica	Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC).
Área responsable de la Información	Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC).
Notas	1. Para el denominador, en caso existan dos o más registros del mismo diagnóstico definitivo de cáncer, considerar el primer registro del diagnóstico definitivo de cáncer. 2. Entiéndase estadio temprano a la etapa inicial de un cáncer: Estadio 0, I y estadio II.

Ficha N° 2: Porcentaje de pacientes con diagnóstico de cánceres prevalentes que inician tratamiento oncológico en un tiempo no mayor a 37 días.

Nombre	Porcentaje de pacientes con diagnóstico de cánceres prevalentes que inician tratamiento oncológico en un tiempo no mayor a 37 días.
Tipo	Indicador de proceso.
Ámbito de Aplicación	Nacional Por tipo de prestador. Por establecimiento
Definición	Porcentaje de pacientes con diagnóstico definitivo de canceres prevalentes que inician tratamientos oncológicos dentro de los 37 días posteriores a la fecha del diagnóstico definitivo de cáncer.
Justificación	El inicio oportuno del tratamiento oncológico mejora los resultados terapéuticos y el pronóstico del paciente.
Fórmula del indicador	N° de pacientes con inicio de tratamiento oncológico <=37 días en relación a la fecha del diagnóstico definitivo de cáncer prevalente ---------- x100 N° total pacientes con diagnóstico definitivo de cáncer prevalente
Construcción del indicador	**Numerador:** Número de pacientes con inicio de tratamiento oncológico <=37 días en relación a la fecha del diagnóstico definitivo de cáncer prevalente. **Denominador:** Número total pacientes con diagnóstico definitivo de cáncer prevalente. **Indicador:** (Numerador/denominador) *100.
Estándar	≥ 80%
Valor basal	Valor obtenido en el año anterior (enero-diciembre).
Valor umbral (logro esperado)	Incremento del 5% sobre el basal del indicador.
Cálculo del porcentaje de cumplimiento	Incremento del valor umbral.
Frecuencia de medición	Trimestral anual acumulada.
Fuente de datos	Herramienta digital de la Red Oncológica Nacional.

Área responsable técnica	Dirección de Prevención y Control del Cáncer de la Dirección General de Intervenciones en Salud Pública del Ministerio de Salud.
Área responsable de la Información	Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del Ministerio de Salud
Notas	1. Para el denominador, en caso existan dos o más registros del mismo diagnóstico definitivo de cáncer, considerar el primer registro del diagnóstico definitivo de cáncer. 2. Entiéndase tratamiento oncológico: Quimioterapia o radioterapia o quirúrgico.

Ficha N° 3: Porcentaje de pacientes con referencia registrada en el establecimiento de salud de destino que cuentan con diagnóstico definitivo de cáncer prevalente, en un tiempo no mayor a 28 días

Nombre	Porcentaje de pacientes con referencia registrada en el establecimiento de salud de destino que cuentan con diagnóstico definitivo de cáncer prevalente, en un tiempo no mayor a 28 días.
Tipo	Indicador proceso.
Ámbito de Aplicación	Nacional Por tipo de prestador. Por establecimiento.
Definición	Porcentaje de pacientes con referencia registrada y aceptada en el establecimiento de salud de destino que obtienen diagnóstico definitivo de cánceres prevalentes dentro de los 28 días posteriores a la fecha de referencia.
Justificación	Contar con un diagnóstico definitivo en un plazo no mayor a 28 días desde la referencia registrada garantiza la continuidad del proceso de atención oncológica, favorece el inicio oportuno del tratamiento y mejora el pronóstico del paciente.
Fórmula del indicador	N° de pacientes con entrega del diagnóstico definitivo de cáncer prevalente <= 28 días en relación a la fecha de referencia registrada para diagnóstico en el establecimiento de destino ---------- x 100 N° total de pacientes referidos para diagnóstico definitivo de cáncer registrados en el establecimiento de salud de destino.
Construcción del indicador	**Numerador:** Número de pacientes con entrega del diagnóstico definitivo de cáncer prevalente <= 28 días en relación a la fecha de referencia registrada para diagnóstico en el establecimiento de destino. **Denominador:** Número total de pacientes referidos para diagnóstico definitivo de cáncer registrados en el establecimiento de salud de destino. **Indicador:** (Numerador/denominador) *100
Estándar	≥ 75%
Valor basal	Valor obtenido en el año anterior (enero - diciembre).
Valor umbral (logro esperado)	Incremento del 5% sobre el basal del indicador.

Cálculo del porcentaje de cumplimiento	Incremento del valor umbral.
Frecuencia de medición	Trimestral anual acumulada.
Fuente de datos	Herramienta digital de la Red Oncológica Nacional.
Área responsable técnica	Dirección de Prevención y Control del Cáncer de la Dirección General de Intervenciones en Salud Pública del Ministerio de Salud.
Área responsable de la Información	Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del Ministerio de Salud.
Notas	1. En caso existan dos o más registros del mismo diagnóstico definitivo de cáncer, considerar al primer registro del diagnóstico definitivo de cáncer. 2. Entiéndase que la referencia registrada debe ser registrada y aceptada. 3. Entiéndase cánceres prevalentes: Cuello uterino, mama, próstata, colon y recto, estómago, cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, linfoma y leucemia).

Ficha N° 4: Tasa de mortalidad estandarizada por edad según tipo de cáncer y región.

Nombre	Tasa de mortalidad estandarizada por edad según tipo de cáncer y región.
Tipo	Indicador de resultado.
Ámbito de Aplicación	Nacional y regional.
Definición	Tasa de mortalidad estandarizada por edad según tipo de cáncer y región.
Justificación	La tasa de mortalidad estandarizada por edad según tipo de cáncer y región es un indicador de desempeño crucial para la Red Oncológica Nacional en Perú, porque funciona como la medida definitiva de la efectividad integral de todos los esfuerzos del sistema de salud contra el cáncer. Su principal valor radica en la estandarización por edad, que elimina el efecto de las diferentes estructuras demográficas (poblaciones más jóvenes o más viejas) al comparar regiones o el progreso a lo largo del tiempo. Esto permite a las autoridades evaluar el riesgo real de morir por cáncer y determinar si las políticas de prevención, detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento están funcionando equitativamente en todo el territorio peruano, que presenta grandes disparidades de acceso. Unas tasas de mortalidad estandarizadas consistentemente altas en el país, o en regiones específicas, indican directamente que existen brechas críticas en el acceso o la calidad de la atención oncológica, lo que a menudo se traduce en diagnósticos tardíos. Monitorear esta tasa es esencial para la priorización de recursos y para evaluar el impacto a largo plazo de las intervenciones para prevenir y controlar el cáncer. En esencia, la tasa estandarizada es el termómetro que mide si el sistema oncológico peruano está logrando su objetivo fundamental: Reducir las muertes evitables por cáncer y mejorar la sobrevida de los pacientes.
Fórmula del indicador	**Tasa ajustada de mortalidad por cáncer:** $\sum_{i=1}^{g-edad} \quad f_{ge} x \frac{Defunciones\ estimadas_{i-edad}}{población_{i-edad}} x100{,}000$ f_{ge}: Fracción de la población estándar al grupo de edad específico (ge) ge: $Grupo\ de\ edad$ $Defunciones\ estimadas_{i-edad}$: Suma de defunciones por cáncer de mama obtenidas de la base de datos de mortalidad estimada. $población_{i-edad}$: Población estimada a la i-edad. La fórmula del indicador corresponde al procedimiento descrito por la OPS en el documento *Tasas de mortalidad por edad estandarizada por Población de 100,000*[1].

[1] Organización Panamericana de la Salud. Tasas de mortalidad por edad estandarizada por población de 100,00. [Internet]. Sitio web de la Organización Panamericana de la Salud; 2009 [citado el 26 de septiembre de

Construcción del indicador	La construcción del indicador sigue el procedimiento descrito por OPS en el documento *Tasas de mortalidad por edad estandarizada por Población de 100,000.*[1]
Estándar	≥ 10% (valor referencial).
Valor basal	Valor obtenido en el año anterior.
Valor umbral (logro esperado)	Reducción anual ≥ 2% en cánceres prevalentes (cuello uterino, mama, próstata, colon y recto, estómago, cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, linfoma y leucemia).
Cálculo del porcentaje de cumplimiento	Disminución del valor umbral.
Frecuencia de medición	1 año.
Fuente de datos	• SINADEF: Base de datos de defunciones estimadas con corrección del subregistro a partir de las defunciones contenidas en el SINADEF. • Estimaciones de población a partir de los censos nacionales de población publicadas por el INEI. • Registro de Cáncer de Base Poblacional.
Área responsable técnica	Dirección de Prevención y Control del Cáncer de la Dirección General de Intervenciones en Salud Pública del Ministerio de Salud.
Área responsable de la Información	Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del Ministerio de Salud. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC).
Notas	

2025]. Disponible en: https://www3.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Tasas-de-mortalidad-por-edad-estandarizadas-hoja-de-resumen.pdf

Ficha N° 5: Tasa de supervivencia a los cinco (5) años del diagnóstico definitivo de cáncer

Nombre	Tasa de supervivencia global de los pacientes diagnosticados de cánceres prevalentes, a 5 años del diagnóstico definitivo.
Tipo	Indicador resultado.
Ámbito de Aplicación	Nacional Por tipo de prestador.
Definición	Tasa de supervivencia de los pacientes diagnosticados de cánceres prevalentes que permanecen vivos a los 5 años después del diagnóstico.
Justificación	La tasa de supervivencia se utiliza como un indicador de la efectividad del tratamiento y la calidad de la atención médica. También se utiliza para comparar los resultados de diferentes tratamientos y para identificar áreas de mejora en la atención médica. La tasa de supervivencia global es un indicador clave que permite evaluar los resultados del control del cáncer y la efectividad del sistema de salud en la detección temprana, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes oncológicos. La supervivencia a 5 años se encuentra alineada con los estándares internacionales (IARC–CONCORD), que permitirá disponer de datos comparables a nivel global, fortaleciendo la evaluación del impacto de las intervenciones nacionales y contribuyendo al seguimiento de los objetivos de la Ley N° 31336, Ley Nacional de Cáncer.
Fórmula del indicador	El cálculo del indicador de supervivencia se realiza mediante el método de estimación de supervivencia de Kaplan-Meier. Este método considera los periodos parciales de seguimiento de los sujetos bajo observación y estima la supervivencia a diferentes periodos (3 y 5 años). Sin embargo, de manera estándar, se utiliza la supervivencia a los 5 años después del diagnóstico como punto de referencia internacional.
Construcción del indicador	La construcción del indicador de supervivencia es un proceso estadístico complejo y se requiere de la siguiente información: Fecha del diagnóstico definitivo (inicio de la medición) y estatus del paciente al término de la medición.
Estándar	≥ 60% en los cánceres prevalentes (cuello uterino, mama, próstata, colon y recto, estómago, cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, linfoma y leucemia).
Valor basal	Valor obtenido en el año anterior (enero-diciembre).
Valor umbral (logro esperado)	Incremento del 5% sobre el basal del indicador.

Cálculo del porcentaje de cumplimiento	Aumento del valor umbral.
Frecuencia de medición	Anual
Fuente de datos	Base de datos del Registro Hospitalario de Cáncer. Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF).
Área responsable técnica	Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC).
Área responsable de Información	Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC).
Notas	El indicador se estima para cada tipo de cáncer.

Ficha N° 6: Porcentaje de establecimientos de salud que reportan información en la herramienta digital de la Red.

Nombre	Porcentaje de establecimientos de salud que reportan información en la herramienta digital de la Red.
Tipo	Indicador de proceso.
Ámbito de Aplicación	Nacional Por tipo de prestador. Por establecimiento.
Definición	El indicador mide el porcentaje de establecimientos de salud.
Justificación	Este indicador permite medir el nivel de cumplimiento y uso de la herramienta digital por parte de los establecimientos de salud, asegurando que la información registrada sea oportuna, confiable y útil para la toma de decisiones. Su seguimiento facilita identificar brechas en el reporte, de información a nivel de la herramienta digital de la RED.
Fórmula del indicador	N° de establecimientos de salud que reportan información en la herramienta digital de la Red ---------- x100 N° total de establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de atención de la Red
Construcción del indicador	**Numerador:** Número de establecimientos de salud que reportan información en la herramienta digital de la Red. **Denominador:** Total de establecimientos de salud del segundo y tercer nivel que pertenecen a la Red. **Indicador:** (Numerador/denominador) *100.
Estándar	≥ 95% de los Institutos Especializados Oncológicos. ≥ 95% de los hospitales que integran la Red.
Valor basal	No definido, toda vez que aún no se cuenta con la herramienta digital de la Red.
Valor umbral (logro esperado)	≥ 95%
Cálculo del porcentaje de cumplimiento	Incremento del porcentaje del valor umbral.

Frecuencia de medición	Trimestral
Fuente de datos	Herramienta digital de la Red
Área responsable técnica	Dirección de Prevención y Control del Cáncer de la Dirección General de Intervenciones en Salud Pública del Ministerio de Salud.
Área responsable de la Información	Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del Ministerio de Salud.
Notas	El reporte se debe realizar en la herramienta digital de la Red, de forma oportuna, es decir, en un plazo no mayor de 30 días.

Ficha N° 7: Porcentaje de pacientes nuevos con diagnóstico definitivo de cánceres prevalentes en la Red Oncológica Nacional.

Nombre	Porcentaje de pacientes nuevos con diagnóstico definitivo de cánceres prevalentes en la Red Oncológica Nacional.
Tipo	Indicador de proceso.
Ámbito de Aplicación	Nacional Por tipo de prestador. Por establecimiento.
Definición	Este indicador permite medir el número de pacientes nuevos diagnosticados (casos confirmados por diagnóstico definitivo) con cánceres prevalentes que reciben atención dentro de la Red Oncológica Nacional en un periodo determinado.
Justificación	Este indicador permite medir el grado de acceso efectivo de la población diagnosticada al sistema especializado de atención oncológica. Es decir, mide la proporción de personas que, una vez confirmada la enfermedad, son atendidas dentro de la Red, asegurando continuidad asistencial desde el diagnóstico hasta el tratamiento.
Fórmula del indicador	N° de pacientes nuevos con diagnóstico definitivo de cánceres prevalentes atendidos en la Red Oncológica Nacional ---------- x100 N° estimado de casos nuevos de cánceres prevalentes
Construcción del indicador	**Numerador:** Número de pacientes nuevos con diagnóstico definitivo de cánceres prevalentes atendidos en la Red Oncológica Nacional. **Denominador:** Número estimado de casos nuevos de cánceres prevalentes. **Indicador:** (Numerador/denominador) *100.
Estándar	≥ 80 % anual.
Valor basal	Valor obtenido en el año anterior (enero-diciembre).
Valor umbral (logro esperado)	Año 1: 65 %. Año 2: 75 %. Año 3: ≥ 80 %.

Cálculo del porcentaje de cumplimiento	Incremento del valor umbral.
Frecuencia de medición	Anual
Fuente de datos	Herramienta digital de la Red Oncológica (numerador). GLOBOCAN (denominador).
Área responsable técnica	Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
Área responsable de la Información	Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del Ministerio de Salud.
Notas	1. En caso existan dos o más registros del mismo diagnóstico definitivo de cáncer, considerar al primer registro del diagnóstico definitivo de cáncer. 2. Entiéndase cánceres prevalentes: Cuello uterino, mama, próstata, colon y recto, estómago, cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, linfoma y leucemia). 3. La fuente del numerador corresponde a la herramienta digital de la Red Oncológica que utilizará el Registro Hospitalario de Cáncer, y la fuente del denominador utilizará el GLOBOCAN (Global Cancer Observatory).

IX. BIBLIOGRAFÍA

1) Castañeda Guillot CD, Castro Sánchez F de J, Martínez R. Desafíos del cáncer en el siglo XXI. CCM [Internet]. 25 de marzo de 2025 [consultado 30 de septiembre de 2025];29:e5223. Disponible en: https://revcocmed.sld.cu/index.php/cocmed/article/view/5223

2) L. Blanch, L. Guerra, A. Lanuza, G. Palomar. Innovación y transferencia tecnológica en ciencias de la salud: Una visión transversal. Rev. Elsevier. [Internet]. Noviembre 2014. [consultado el 30 de septiembre de 2025];38(8):492-497. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0210569114001375

3) Arnold M, Rutherford MJ, Bardot A, et al. Progress in cancer survival, mortality, and incidence across seven high-income countries (ICBP SURVMARK-2). Lancet Oncol. 2019;20(11):1493–1505.

4) Trama A, Rossi S, Bennet D, Stiller C, Paapsi K, Troussard X, Giudici F, Karim-Kos H.E, Cerza F, Trallero J, Ragusa R, Blum M, Mayer-da-Silva A; EUROCARE-6 Working Group. Results from EUROCARE-6, a population-based study: 5-year relative survival estimates for cancer patients in Europe. Eur J Cancer. 2025;226:115535.

5) Organización Panamericana de la Salud / World Health Organization. *NCDs at a Glance 2025:* Surveillance and monitoring of noncommunicable disease mortality and risk factor prevalence in the Region of the Americas, 2000–2021 [Internet]. Washington, DC: PAHO/WHO; 2025. Disponible en: https://www.paho.org/en/node/99160

6) Registros Poblacionales de Cáncer en Brasil: Relevancia, Desafíos y Oportunidades. Rev. Bras. Cancerol. [Internet]. 3 de febrero de 2025 [consultado el 30 de septiembre de 2025];71(1):e-104878. Disponible en: https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista/article/view/4878

7) Silva FA, Trindade ES, Santiago BG, Afonso GV, Santos HLPC dos, Prado NM de BL. Políticas de salud pública para combatir el cáncer en Brasil: Análisis de los planes estatales de atención oncológica. Rev. Bras. Cancerol. [Internet]. 5 de abril de 2024 [consultado el 30 de septiembre de 2025];70(1): e-144454. Disponible en: https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista/article/view/4454